

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE MOTIVACIÓN INTRÍNSECA (IMI-22)

Eje III: Personalidad • Evaluación de la Motivación Autodeterminada y la Experiencia Subjetiva de Tarea

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Motivación Intrínseca (IMI: 22 reactivos).
Nombre Original	Intrinsic Motivation Inventory (IMI; Ryan, 1982; McAuley et al., 1989).
Autores Originales	Dr. Richard M. Ryan y Dr. Edward L. Deci (Universidad de Rochester).
Adaptaciones Hispanas	Balaguer et al. (2008), Universidad de Valencia; Pereira et al. (2015), España.
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad. Motivación intrínseca: interés/disfrute, competencia, esfuerzo y tensión.
Tipo de Instrumento	Autoinforme situacional de 22 reactivos con escala Likert de 7 puntos (1 a 7).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 12 años). Ámbito educativo, deportivo, laboral y clínico.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico, formativo y de investigación científica bajo citación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN (SDT)

El **Inventario de Motivación Intrínseca** (IMI; Ryan, 1982; Deci & Ryan, 2000) se fundamenta de forma directa en la Teoría de la Autodeterminación (**Self-Determination Theory** - SDT), específicamente en la Teoría de la Evaluación Cognitiva (CET). La **motivación intrínseca** describe la propensión innata del ser humano a involucrarse en actividades por el placer, desafío y satisfacción inherentes a la propia tarea, en ausencia de recompensas contingentes externas o presiones coercitivas.

El IMI evalúa de forma multidimensional la experiencia subjetiva del sujeto respecto a una actividad diana mediante cuatro subescalas cardinales:

- Interés / Disfrute:** Constituye el criterio directo y autopercepción central de la motivación intrínseca (“me pareció entretenido y muy ameno”).
- Competencia Percibida:** La creencia en la propia efectividad y maestría al ejecutar la tarea.
- Esfuerzo / Importancia:** La inversión intencional de energía y compromiso depositado en la actividad.
- Presión / Tensión:** La experiencia de estrés ansioso, agobio o coerción (correlato negativo del disfrute intrínseco).

Neurobiológicamente, el disfrute intrínseco se asocia a una sostenida liberación fásica de dopamina en el estriado ventral y a una activación coordinada de la corteza prefrontal ventromedial y la corteza cingulada anterior, favoreciendo la consolidación sináptica de aprendizajes complejos y el estado de fluidez cognitiva (flow).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Subescala IMI	Ítems (22)	Nº Ítems	Definición Operativa del Constructo
1. Interés / Disfrute	1, 5, 8, 10, 14*, 17, 20	7 ítems	Placer intrínseco, diversión y satisfacción generada por la actividad.
2. Competencia Percibida	4, 7, 12, 16*, 22	5 ítems	Sentimiento de maestría, eficacia y habilidad durante la ejecución.
3. Esfuerzo / Importancia	2*, 6, 9, 13, 19	5 ítems	Inversión subjetiva de empeño, laboriosidad y persistencia.
4. Presión / Tensión	3, 11*, 15, 18, 21	5 ítems	Vivencia de ansiedad, nerviosismo, coerción o angustia ante la tarea.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión en adaptaciones españolas (Balaguer et al., 2008; Pereira et al., 2015): alfa de Cronbach de 0.86 a 0.91 para Interés/Disfrute, 0.82 a 0.87 para Competencia, 0.80 a 0.84 para Esfuerzo y 0.78 a 0.82 para Tensión; coeficientes omega de McDonald superiores a 0.82. Estabilidad test-retest $r = 0.76$ a 4 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora la solución tetrafactorial intercorrelacionada (CFI = 0.95, TLI = 0.94, RMSEA = 0.049). Interés/Disfrute se sitúa como factor núcleo correlacionando positivamente con Competencia y negativamente con Tensión.
Validez Concurrente	Correlación directa elevada con Autoeficacia (GSE, $r = 0.54$), Vitalidad Subjetiva ($r = 0.56$) y Adherencia al Tratamiento/Entrenamiento ($r = 0.49$). Correlación inversa con Apatía, Burnout y Abandono temprano de programas terapéuticos.
Sensibilidad Experimental	Alta sensibilidad comprobada al estilo motivacional del terapeuta/entrenador (autonomía vs. controlador), registrando caídas abruptas en disfrute cuando se emplean recompensas externas contingentes coercitivas.
Invarianza de Medida	Invarianza métrica demostrada a través de diferentes disciplinas y contextos de aplicación.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada reactivo se califica en una escala Likert de 7 puntos:

- **Opciones de Respuesta:** 1 = «Para nada cierto», 2 = «Apenas cierto», 3 = «Poco cierto», 4 = «Neutral», 5 = «Algo cierto», 6 = «Mayormente cierto», 7 = «Muy cierto».
- **Paso 1 (Inversión de Ítems Inversos):** Se invierten 5 reactivos marcados con asterisco (Ítems 2, 11, 14, 16 y 21):

$$\text{Ítem Invertido} = 8 - \text{Respuesta Original}$$

(De modo que: 1 pasa a 7; 2 pasa a 6; 3 pasa a 5; 4 permanece 4; 5 pasa a 3; 6 pasa a 2; 7 pasa a 1).

- **Paso 2 (Medias de Subescala):** Se calcula la **media aritmética simple** de los reactivos de cada subescala (con los ítems ya invertidos):

$$\text{Media de Subescala} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \text{Ítem}_i$$

(Rango: **1.00 a 7.00 puntos** por subescala).

- **Nota Clínica:** No se calcula una puntuación total combinada; se analiza el perfil cuadrangular.

6. BAREMOS NORMATIVOS Y ESTRATIFICACIÓN DEL PERFIL MOTIVACIONAL (MEDIA 1 A 7)

Estratificación	Media Dimensional	Nivel de Motivación	Interpretación y Manifestación en Consulta
Bajo	1.00 a 3.49 pts	Motivación intrínseca deficiente	La actividad se percibe tediosa, aversiva o generadora de desinterés radical. Riesgo de deserción.
Moderado	3.50 a 4.99 pts	Motivación media / Normativa	Compromiso funcional; adecuado balance entre esfuerzo y disfrute condicionado por metas.
Alto	5.00 a 5.99 pts	Alta autodeterminación	Placer intrínseco elevado, sentimiento de eficacia y absorción productiva en la tarea.
Muy Alto	6.00 a 7.00 pts	Flujo óptimo (≥ 6.00)	Experiencia óptima de disfrute (flow), alta creatividad y total involucramiento intrapersonal.

ALERTA DE DESERCIÓN TERAPÉUTICA: Tensión Elevada (Media ≥ 5.00):

Si la subescala de **Presión / Tensión** supera **5.00** y el **Interés / Disfrute** cae por debajo de **3.00**, el paciente percibe las tareas intersesiones (autorregistros, exposiciones) como una imposición coercitiva abrumadora. Predecir abandono inminente y flexibilizar el encuadre.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE APOYO A LA AUTONOMÍA BASADO EN EL IMI (SDT)

PROTOCOLO DE REESTRUCTURACIÓN DE TAREAS TERAPÉUTICAS:

- **Paso 1 (Identificación del Factor Inhibidor):** Evaluar si la baja adherencia procede de baja Competencia (ítems 4, 7, 12, 16, 22) o de alta Tensión/Presión (ítems 3, 11, 15, 18, 21).
- **Paso 2 (Cesión de Autonomía y Elección):** Ofrecer al paciente alternativas de formato para sus tareas (ej. elegir entre escribir un diario, grabar notas de voz o usar una app móvil), explicando siempre el "porqué" funcional de la intervención.
- **Paso 3 (Ajuste de Dificultad para Fomentar Competencia):** Si Competencia < 3.50, simplificar la tarea para asegurar sensaciones de maestría inmediata y desactivar el juicio evaluativo.
- **Paso 4 (Criterio de Consolidación):** Un Interés/Disfrute ≥ 4.50 con Tensión < 3.00 consolida la motivación intrínseca y la adherencia autónoma a largo plazo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN RECHAZO A TAREAS DE ACTIVACIÓN CONDUCTUAL

Identificación: Varón de 41 años en tratamiento por episodio depresivo mayor, acude a la 4ª sesión sin haber completado los registros de actividades placenteras programados ("me siento obligado como si tuviera que rendir cuentas al colegio y me da angustia").

Evaluación Inicial IMI (sobre la tarea de autorregistro): Presión / Tensión = 6.20/7.00 (alta vivencia coercitiva); Interés / Disfrute = 1.86/7.00 (rechazo aversivo de la tarea); Competencia Percibida = 2.40/7.00; Esfuerzo = 5.60/7.00 (gran desgaste con nulo fruto).

Ajuste Metodológico Basado en SDT: El terapeuta reconoció el fallo del encuadre directivo anterior, eliminó las hojas de registro formales y propuso co-diseñar un microexperimento elegido libremente por el paciente: dar un paseo de 15 minutos fotografiando grafitis urbanos sin obligación de apuntar nada.

Reevaluación IMI (siguiente semana): Presión/Tensión se desplomó a 2.00/7.00; Interés/Disfrute se disparó a 5.71/7.00; Competencia subió a 5.40/7.00. El paciente recuperó la tracción terapéutica y continuó la activación conductual de manera espontánea.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

TENSIÓN CRÓNICA Y RIESGO DE ABANDONO:

Una Tensión media ≥ 5.50 mantenida en psicoterapia predice una ruptura de la alianza terapéutica en las siguientes dos sesiones si el clínico no reduce la exigencia y cambia a un estilo empático no evaluativo.

FALSA MOTIVACIÓN COMPLACIENTE:

Puntuaciones de 7.00 en Disfrute y Esfuerzo en pacientes con alta deseabilidad social pueden reflejar sumisión complaciente para agradar al terapeuta y no verdadera autodeterminación (contrastar con lenguaje no verbal).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Ryan, R. M. (1982). Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory. *JPSP*, 43(3), 450-461.
2. McAuley, E., Duncan, T., & Tammen, V. V. (1989). Measuring intrinsic motivation in sport: The Intrinsic Motivation Inventory. *Res Q Exerc Sport*, 60(1), 48-58.
3. Balaguer, I., Castillo, I., Duda, J. L., & García-Merita, M. (2008). Propiedades psicométricas del Inventario de Motivación Intrínseca en deportistas valencianos. *Revista de Psicología del Deporte*, 17(1), 73-89.
4. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.